Lacticaseibacillus paracasei によるカテーテル関連血流感染の 1 症例

◎吉田 美穂[1)]、池戸 政博[1)]、竹内 優里[1)]
名鉄病院[1)]

【はじめに】*Lacticaseibacillus paracasei* はヒトの口腔内や腸管，膣の常在菌叢を構成するグラム陽性桿菌である。近年ではプロバイオティクスとして用いられ，感染症の原因菌としての報告は稀である。今回我々は *L. paracasei* によるカテーテル関連血流感染(CRBSI)を経験したので報告する。【症例】90 歳代，女性。右結石性腎盂腎炎にて入院。来院時の血液培養より ESBL 産生菌が検出され，MEPM，CMZ，T/P が投与されていた。状態が安定し，経尿道的尿路結石砕石術を施行した。術後，血液培養より *Candida albicans* が検出され，MEPM，F-FLCZ が投与されていたが，末梢静脈の確保が困難となり，鼠径部より CV カテーテルが留置された。留置+14 日後に発熱を認め，CRBSI が疑われた。翌日 CV カテーテルが抜去され，カテーテル先端および血液培養 2 セットが提出された。血液培養およびカテーテル先端培養より *L. paracasei* が検出された。【微生物学的検査】グラム染色にて連鎖形成のあるグラム陽性短桿菌を認めたが，球菌か桿菌かの判別が困難であった。サブカルチャーは血液寒天培地を用いて 5%CO_2 環境下で 35℃48 時間培養を行い，非溶血性の白色小コロニーの発育を認めた。WalkAway によるパネル同定は不能であったが，薬剤感受性検査において VCM の MIC が>16 μg/mL であったため，本質的に耐性を示す *Leuconostoc* spp.または *Lactobacillus* spp.が推定される旨を中間報告した。検査センターへ解析依頼し，MALDI-TOF MS にて *L. paracasei* と同定された。【考察】本菌を原因とする感染症の報告は乳酸菌飲料等を常飲する患者において散見されるが，本患者において摂取歴はなかった。患者は外科的処置後の免疫抑制状態にあり，便失禁も繰り返していたため，カテーテル刺入部である鼠経部が汚染され，本菌が留置カテーテルに定着した可能性が考えられる。また，複数の抗菌薬を使用し，これらの抗菌薬に耐性を示す本菌が選択された可能性がある。【結語】CRBSI の原因菌として頻度が高い病原体は CNS や MRSA，*Enterococccus* spp.であり，VCM が第一選択薬として推奨されている。しかし本菌はVCMに本質的に耐性を示すため，臨床側への速やかな情報提供が重要である。連絡先 052-551-6121(内線 8306)